

SEMIOLOGÍA CARDIACA

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

1.- INSUFICIENCIA CARDIACA

Insuficiencia Cardíaca izquierda

- Se caracteriza por síntomas respiratorios: ortopnea, disnea paroxística nocturna y disnea de esfuerzos.
- Puede producir edema pulmonar agudo.

Insuficiencia Cardíaca Derecha

- Se caracteriza por síntomas sistémicos y congestión venosa: astenia, ingurgitación yugular, edema de extremidades inferiores, congestión hepática (hepatomegalia, hepatitis congestiva que puede evolucionar a la "cirrosis cardíaca").
- No produce edema pulmonar, sino corporal.

Insuficiencia Global

- Tiene tanto síntomas de ICC derecha, como de ICC izquierda.

Disfunción sistólica

- Suele asociarse a cardiomegalia (hipertrofia excéntrica), con desplazamiento del choque de la punta.
- Puede tener un R3. La presencia de R3 es muy sugerente de ICC con disfunción sistólica.
- El ECG suele mostrar signos de HTVI.

Disfunción diastólica

- Suele asociarse a hipertrofia concéntrica, sin cardiomegalia.
- Puede tener un R4. La presencia de R4 es muy sugerente de ICC con disfunción diastólica. El R4 desaparece si hay fibrilación auricular, ya que se produce por la contracción auricular.
- El ECG también suele mostrar signos de HTVI.

2.- VALVULOPATÍAS

LADO IZQUIERDO: Todas las valvulopatías mitrales y aórticas presentan síntomas de ICC izquierda.

Estenosis Mitral

- Soplo diastólico, en rodada. El soplo puede tener un refuerzo presistólico, por la contracción auricular (también este refuerzo desaparece en la fibrilación auricular).
- R1 aumentado de intensidad.
- Chasquido de apertura.
- Chapas mitrálicas (eritema violáceo en las mejillas).
- Hemoptisis.
- Asociado a dilatación de la aurícula izquierda (que a su vez se asocia de fibrilación auricular).

Insuficiencia Mitral

- Soplo sistólico, de tipo holosistólico.
- R1 de intensidad disminuida.
- Asociado a dilatación tanto del ventrículo izquierdo (hipertrofia excéntrica), como de la aurícula izquierda.

Estenosis Aórtica

- Soplo sistólico, de tipo mesosistólico o eyectivo. Suele irradiarse al cuello.
- R2 disminuido de intensidad.
- Click de apertura.
- Síncopes relacionados con el esfuerzo.
- Angina de pecho.
- Muerte súbita
- Asociado a dilatación de la aurícula izquierda e hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo.
- Pulso filiforme o pulso parvus et tardus (pequeño y lento).

Insuficiencia Aórtica

- Soplo diastólico (aspirativo). Suele irradiarse al cuello.
- Puede tener soplo de Austin Flint.
- R2 disminuido de intensidad.
- Asociado a dilatación del ventrículo izquierda. Gran cardiomegalia.
- Pulso amplio o pulso Cellier.
- Danza arterial.

Hipertensión arterial (no es valvulopatía)

- Aumenta la intensidad de R2.

VALVULOPATÍAS

LADO DERECHO: Todas las valvulopatías pulmonares y tricuspideas presentan síntomas de ICC derecha. Además los soplos y otros ruidos (clicks, chasquidos, etc.) aumentan con la inspiración.

Estenosis Pulmonar

- Sopro sistólico, de tipo mesosistólico o eyectivo.
- R2 disminuido de intensidad.
- Click de apertura.
- Asociado a dilatación de la aurícula derecha e hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho.

Insuficiencia Pulmonar

- Sopro diastólico (aspirativo).
- R2 disminuido de intensidad.
- Dilata ventrículo derecho.

Estenosis Tricuspídea

- Sopro diastólico, en rodada. El soplo puede tener un refuerzo presistólico, por la contracción auricular (también este refuerzo desaparece en la fibrilación auricular).
- R1 aumentado de intensidad.
- Chasquido de apertura.
- Asociado a dilatación de la aurícula derecha (que a su vez se asocia de flutter auricular).
- Pulso venoso con onda "a" gigante.

Insuficiencia Tricuspídea

- Sopro sistólico, de tipo holosistólico.
- R1 de intensidad disminuida.
- Asociado a dilatación tanto del ventrículo derecho, como de la aurícula derecha.
- Pulso venoso con onda "v" aumentada de tamaño.

Hipertensión Pulmonar (no es valvulopatía)

- Aumenta la intensidad de R2, lo que se exacerba con la inspiración.

ENFERMEDAD VALVULAR: Se llama enfermedad valvular a la concurrencia de estenosis e insuficiencia en una misma válvula. Tendrá clínica mezclada de ambas.

3.- MIOCARDIOPATÍAS

Miocardopatía Dilatada

- Síntomas de insuficiencia cardiaca izquierda o global.
- Cardiomegalia y desplazamiento del choque de la punta (hipertrofia excéntrica).
- El ECG muestra signos de HTVI. Además puede mostrar signos de HTVD y/o de las aurículas.
- Puede tener además clínica de insuficiencia mitral, porque el anillo valvular puede dilatarse demasiado.
- Suele ser en pacientes jóvenes o con algún antecedente (Chagas, consumo de alcohol, etc).

Miocardopatía Hipertrófica

- Síntomas de ICC izquierda.
- Angina de pecho.
- Síncopes.
- Muerte súbita.
- Suele ser en pacientes más jóvenes.
- El ECG muestra signos de HTVI. Además puede mostrar signos de hipertrofia del VD o de las aurículas. Además suele tener ondas T invertidas y gigantes en las derivaciones precordiales.
- La radiografía de tórax muestra corazón de tamaño normal (hipertrofia concéntrica).

Miocardopatía Hipertrófica Obstructiva

- A lo anterior se agregan otros síntomas y signos.
- Soplo sistólico eyectivo (mesosistólico), que aumenta con la maniobra de Valsalva y disminuye al ponerse en cuclillas.
- Pulso Celler (amplio).
- Pulso bisferiens.
- Es fácil confundirla con la estenosis aórtica (tienen en común los síntomas de ICC izquierda, la angina, los síncopes, la muerte súbita, el soplo eyectivo, la hipertrofia concéntrica), pero suele darse en pacientes más jóvenes y además tiene algunas diferencias (ondas T invertidas gigantes del ECG, soplo aumenta con Valsalva y disminuye en cuclillas y el pulso es amplio y bisferiens, mientras que en la estenosis aórtica es parvus et tardus).

Miocardopatía Restrictiva

- Síntomas de ICC global.
- Rápido deterioro de la capacidad funcional.
- Suele venir con antecedente de amiloidosis o algo así.

4.- ENFERMEDADES DEL PERICARDIO

Pericarditis aguda

- Dolor torácico que aumenta con la inspiración profunda y que disminuye al inclinarse hacia adelante (posición genupectoral o mahometana).
- Suele ser en personas jóvenes.
- ECG muestra depresión del PR y SDST en "J" en las derivaciones precordiales (V1 a V6).
- Puede tener frotos pericárdicos.

Pericarditis constrictiva

- Síntomas de ICC derecha.
- Signo de Kussmaul (las yugulares se ingurgitan al inspirar profundo. Lo normal es que se colapsen).
- Ingurgitación yugular.
- Colapso "y" prominente en el pulso venoso.

Derrame pericárdico

- Puede ser asintomático.
- Ruidos cardíacos de baja intensidad.
- Si es grave produce síntomas de taponamiento.
- El ECG puede mostrar alternancia eléctrica.

Taponamiento

- Hipotensión arterial.
- Yugulares ingurgitadas.
- Además la clínica de derrame pericárdico.
- También otros síntomas de ICC derecha, en particular si es crónico o subagudo.

5.- COMPLICACIONES MECÁNICAS DEL INFARTO

Todas suelen aparecer entre el día 2 y 7 postinfarto. Todas se diagnostican con ecocardiografía y se tratan con cirugía.

Rotura del músculo papilar

- Produce una insuficiencia mitral aguda, con toda la clínica de esta (soplo holosistólico, etc.).
- Descompensa al paciente infartado.

Rotura del tabique interventricular

- Produce una comunicación interventricular aguda, con toda la clínica de esta (soplo holosistólico, etc.).
- Puede ser indistinguible de una rotura de músculo papilar (la Ecocardiografía las diferencia).

Rotura de la pared libre ventricular

- Produce un taponamiento agudo, con toda su clínica (hipotensión, ingurgitación yugular, etc.).

Aneurisma / Pseudoaneurisma ventricular

- Produce trombos ventriculares y embolias de origen cardíaco.
- Lo clásico es que el ECG muestra un SDST persistente, a pesar de que ya no tiene dolor torácico y que el IAM sucedió hace varios días o semanas.
- El aneurisma mantiene las 3 capas del corazón (pericardio, miocardio y endocardio), mientras que el pseudoaneurisma pierde alguna de ellas. Clínicamente son iguales (embolias y SDST).

6.- CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

ACIANÓTICAS:

- Síntomas de ICC.
- Mal incremento ponderal.
- Se cansa al mamar o bien intolerancia al ejercicio, si es un niño más grande.
- Infecciones respiratorias a repetición.
- Todas las acianóticas tienen síntomas similares, aunque cada una tiene signos y algunos síntomas específicos.
- Como tienen hiperflujo pulmonar, pueden tener cianosis, pero que sí mejora con O2.

Comunicación interventricular

- Soplo sistólico, de tipo holosistólico.
- Dilatación de las cavidades izquierdas en la RxTx.
- Signos de hipertrofia de las cavidades izquierdas en el ECG.

Comunicación interauricular

- Soplo sistólico, de tipo mesosistólico o eyectivo. Se produce por el hiperflujo pulmonar.
- Desdoblamiento fijo del R2.
- Dilatación de las cavidades derechas en la RxTx.
- Signos de hipertrofia de las cavidades derechas en el ECG.

Ductus arterioso persistente

- Soplo sistólico y diastólico, llamado también soplo continuo o soplo en maquinaria.
- Dilatación de las cavidades izquierdas en la RxTx.
- Signos de hipertrofia de las cavidades izquierdas en el ECG.

Canal aurículoventricular

- Soplo sistólico, de tipo holosistólico.
- Dilatación de las cavidades izquierdas en la RxTx.
- Signos de hipertrofia de las cavidades izquierdas en el ECG.
- Es decir igual a la CIV, pero suele darse en pacientes con Sd. de Down.

Coartación aórtica

- Soplo sistólico, de tipo mesosistólico o eyectivo.
- Debilidad de los pulsos de las EEII.
- En casos extremos tiene el signo del arlequín (bebé con piernas y tronco bajo de color blanco por isquemia).
- Suele asociarse a hipertensión, similar a la renovascular.

CIANÓTICAS:

- Todas tienen cianosis, que no responde a O2 al 100%.
- Algunas tienen soplos.
- Algunas son ductodependiente y si el ductus se cierra, el paciente muere, como en la transposición de grandes vasos (también llamada transposición de grandes arterias). La TGV o TGA suele no tener soplos.
- Solo la ecocardiografía las distingue entre ellas.
- Ejemplos: Tetralogía de Fallot, tronco arterioso, atresia tricuspídea, ventrículo único, TGA, etc.

7.- OTRAS

Infarto agudo al miocardio

- Dolor torácico opresivo, intenso.
- Irradiación al cuello, a la mandíbula o a los hombros.
- En los diabéticos puede no haber dolor, sino solo malestar.
- En los IAM de pared inferior, el dolor puede ser abdominal, epigástrico.
- Síntomas de insuficiencia cardíaca.
- Síntomas simpáticos: palpitaciones, sudoración.
- Puede haber R4 porque el ventrículo se rigidiza y se produce disfunción diastólica.
- También puede haber R3, si hay ICC con disfunción sistólica.
- El ECG muestra signos de isquemia: Onda Q (o complejos QS), alteraciones del ST (IDST y SDST) y alteraciones de la onda T (inversión, aplanamiento, onda T bifásica).

Dissección aórtica

- Dolor torácico intenso, transfixiante.
- Irradiación al dorso.
- Soplo de insuficiencia aórtica (diastólico), si se diseca la válvula aórtica.
- Puede tener asimetría de pulsos radiales.
- Puede tener abolición o disminución de los pulsos de las EEII.
- Disfonía aguda, si afecta el nervio laríngeo recurrente.
- Radiografía de tórax puede mostrar un mediastino ancho.
- ECG suele estar normal.

Infarto de ventrículo derecho

- Hipotensión arterial.
- Yugulares ingurgitadas.
- Examen pulmonar normal.
- Asociado a IAM de pared inferior.
- Muy similar a un taponamiento (por rotura de la pared libre, por ejemplo), con la diferencia que suele darse junto con el IAM y se asocia al de pared inferior.